

Información Paciente

Nombre : Carlos Manuel Trujillo Peña
Edad : 69a 3m 19d
Dirección : Cipres De Las Huaitecas 3682

Rut : 6.281.696-1
Fecha Nacto: 09/12/1952
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1208882
Sexo : Masculino
Teléfono : 978327141

N° Epicrisis
296840

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 10/02/2022 03:00

Días Estadía: 46

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básic

Fecha Egreso : 28/03/2022 14:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

COVID

Comorbilidades

Hipertensión Arterial; Insuficiencia Renal Crónica; Fibrilación Auricular;

Procedimientos

04/03/2022 - Endoscopia Digestiva Alta (Ligadura Varices, Gastrostomía, Biopsias)
17/03/2022 - Punción Diagnóstica Bajo Tac/Ecografía

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

- Infec: Neumonía asociada a ventilación mecánica - Germen: Proteus Mirabilis
- Infec: Itu - Germen: Enterococo Faecalis
- Infec: Colonización - Germen: Klebsiella BLEE

Resumen Clínico

Antecedentes

- Mórbidos: Hipertensión arterial, Fibrilación auricular, Enfermedad renal crónica etapa IIIb (crea 1.67 sept 2021)
- Quirúrgicos: Cx de próstata
- Fármacos: Atenolol 25 mg al día, Losartán 25 mg al día, Omeprazol 20 mg al día, acenocumarol según esquema
- Alergias: Niega
- Inmunizaciones: Sinovac 3 dosis, Flu 2021
- Hábitos: TBQ (-), OH (-), drogas (-)
- Hospitalizaciones reciente: No
- Social: Vive con su esposa. Autovalente. Teléfonos de contacto: 977787181 - 944836607

Historia actual:

Hombre de 69 años con antecedentes descritos, consulta por cuadro iniciado el 06/02 de CEG, sensación febril, odinofagia, disfonía y diarrea. Niega disnea, dolor torácico y dolor abdominal. Es presentado para residencia sanitaria, donde se pesquisa desaturación y requerimientos de O2 por lo que se deriva a SU CASR.

Ingresa el 10/02 en malas condiciones generales, normotenso, taquicárdico (102), afebril, saturando 95% con 15 litros de O2. Al examen físico con MP (+) y crépitos bilaterales finos sin UMA.

Lab: 10/02: Hb 16.1, Hto 49.5, VCM 92, CHCM 32, GB 10540, RAN 9500, plq 164000, INR 2.02, TTPA 40, lactato 29, PCR 207, crea 3.24, BUN 58, ELP 133/5.4/105, Ca 9.3, alb 3.4, glucosa 121, FA 56, GGT 42, biliT 0.9, GOT 82, GPT 39, TUS 15.5, LDH 860

TC de tórax compatible con neumonía por COVID-19.

Se inicia manejo con corticoides y oxígeno por MMV FiO2 50%, bajando rápidamente requerimientos de O2 hasta naricera 4 litros. Inicialmente se hospitaliza en UTIM donde presenta mala evolución requiriendo VMI.

Se describe evolución por sistemas.

1.Hemodinamia: Requerimientos de DVA a dosis bajas en contexto de shock y sedación. Resto de hospitalización (fuera de UPC) con PA limite inferior pero buena perfusión clínica.

Fecha Epicrisis : 28/03/2022 13:32

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 28-03-2022 13:32:45

Página 2 de 4

Presenta FA con RVR que semaneja con BIC de amiodarona en 2 oportunidades. Actualmente solo con bisoprolol con FC dentro de metas.

Ecocardiograma 21/03 VI tamaño normal, función sistólica global y segmentaria normal. FEVI 60%. Llenado monofásico por FA. Dilatación biauricular. Reflujo mitral leve inespecífico. VD de tamaño y función normal

2. Respiratorio: Ingresa con insuficiencia respiratoria aguda grave 2da a COVID.

TC de tórax con extenso infiltrado en vidrio esmerilado. Se conecta a VMI 11/02. Requiere bloqueo neuromuscular 24 hrs. Buena evolución de intercambio. Extubado el 19/02 con salida a CNAF. Con destete progresivo, con requerimientos intermitentes a bajos flujos de oxígeno. Suspendido definitivamente el oxígeno el 21/03. Permanece en rehabilitación y KTR.

3. Infeccioso: Intercurrencias en hospitalización

a.- NAC COVID-19: Se maneja con 10 días de dexametasona

b.- NAVM por P. mirabilis tratada con ampicilina/sulbactam por 7 días.

c.- ITU por Enterococo faecalis MS recibiendo ampicilina / sulbactam por 7 días.

d.- K. oxytoca BLEE en CAET 17/02 no tratada.

e. ITU febril se inicia amikacina UC 1 PMB, UC 2 01/03/22 + PSAE MS. Elevación de parámetros inflamatorios persistente se indica tratamiento con Imipenem que completa 3 días.

f.- Pcte afebril pero con elevación de parámetros inflamatorios. Se realiza TC TAP 15/03 que describe: Colecciones hipodensas en ambos músculos ilíacos, de mayor tamaño a derecha, el diagnóstico diferencial, debe considerar abscesos versus hematomas-sobreinfectados.

Se puncionan por radiología intervencional, líquido de carácter hemático y con cultivos negativos. De todas formas recibe curso corto empírico con imipenem por 7 días con buena respuesta. PI normalizados. Control imagenológico con estabilidad de lesiones. Se mantiene afebril y estable se considera baja posibilidad de sobreinfección.

4. Renal/Urológico: Previamente cursando AKI prerrenal sobre ERC (crea de ingreso 3.24), se indica volemicación con buena respuesta. En TC de 15/03 se evidencia Globo vesical. Moderada hidroureteronefrosis bilateral. Moderado aumento de volumen prostático.

Se instala Foley permanece con crea en su basal 1.38 con resolución imagenológica de HUN. Se decide sonda permanente iniciando tamsulosina y prueba miccional en ambulatorio.

5. Gastro: sin exteriorización de sangrado pero con caída sostenida de la Hb.

EDA muestra Úlcera forrest III y cicatriz de úlcera subcardial, gastropatía erosiva antral, bulboduodenitis erosiva, hernia hiatal, esofagitis los angeles A distal. Se mantiene IBP doble dosis por compromiso extenso. No se realiza biopsia por INR 1.7. Sin nueva caída de Hb. EDA + biopsia se difiere para ambulatorio

Colelitiasis. Sin alteración de pruebas hepáticas. A resolver en ambulatorio

6. ETE: Con TACO por FA, recibiendo inicialmente con HBPM en plan de traslape. Dado HDA y hematomas descritos se mantiene suspendida resto de hospitalización y al alta hasta nuevo control con imagen que muestre disminución de tamaño de hematomas.

Como hallazgo el 17/03 TEP agudo bilateral, sin signos de sobrecarga de cavidades cardíacas derechas. TVP vena ilíaca externa, vena femoral común y femoral derechas. Disminución en la extensión y densidad de las múltiples opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales.

Como parte de estudio de TEP no provocado pcte cuenta con EDA. Debe realizarse estudio acorde con edad con Colonoscopia, próstata y piel.

7. Rehabilitación:

- Motor: Logra sedente borde cama y caminar con andador con ruedas.

- Deglución: en seguimiento por FNA, se progresa a régimen blando sin granos + liq claros bien tolerado

- Delirium: Hiperactivo en UCI, requirió BIC de Precedex ya suspendida. cursa con desorientación en tiempo y espacio, sin nueva focalidad neurológica. impresiona en relación uso de clonazepam. TC de cerebro s/cte sin informe no impresiona con lesiones agudas.

Diagnósticos de egreso:

1.- TEP central bilateral provocado + TVP vena ilíaca externa, vena femoral común y femoral derechas

2.- Colección a nivel de psoas bilateral (hematoma)

3.- AKI sobre ERC IIIb

Fecha Epicrisis : 28/03/2022 13:32

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 28-03-2022 13:32:45

Página 3 de 4

a.- Prerenal por Sepsis COVID

b.- Post-renal HUN bilateral

4.- Miopatía del paciente crítico

5.- Anemia moderada en estudio -Hemorragia digestiva alta + hematoma psoas

a.- Úlcera forrest III en region subcardial

b.- Cicatriz de úlcera en region subcardial

c.- gastropatía erosiva en antro/ bulboduodenitis erosiva/ hernia hiatal pos deslizamiento/ esofagitis grado a en tercio

dista

Resultos

Insuficiencia respiratoria aguda-COVID 19

a.-VMI 12/02 al 19/02

HITS infecciosos resueltos:

a.Traqueobronquitis/MAVM P mirabilis

b.ITU por E. faecalis

c. ITU febril tratada PSAE MS 01/03

Hipernatremia leve resuelta

Delirium mixto

FA con RVR

Antecedentes: HTA, FA en TACO, ERC etapa IIIb (crea 1.31)

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Aguda - Neumonía Grave X Covid 19

Trombosis Venosa profunda - Tep Bilateral + Tvp Vena Ilíaca Externa, Vena Femoral Común Y Femoral Derechas

Colección A Nivel De Psoas Bilateral (Hematoma) - Colección A Nivel De Psoas Bilateral (Hematoma)

Insuficiencia Renal Aguda Sobre Crónica -

Miopatía Del Paciente Crítico -

Hemorragia Digestiva Alta - Anemia Moderada -Hemorragia Digestiva Alta + Hematoma Psoas

Traqueobronquitis/Mavm P Mirabilis -

Itu Por E. Faecalis -

Hipernatremia Leve Resuelta -

Fibrilación Auricular Con Respuesta Ventricular Rápida -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

En buenas condiciones generales, hemodinamia estable sin dificultad respiratoria ni requerimientos de oxígeno, afebril.

Se presenta a UHD para continuar rehabilitación motora.

Plan Post Alta

Hemodinamia: control de PA y frecuencia cardíaca en relación a FA. Por ahora mantener solo bisoprolol a dosis bajas.

Según evolución agregar IECA.

Renal/Urológico:

Acudir a control por nefrología para prevención de progresión de ERC.

Se indica inicio con tamsulosina para realización de prueba miccional en 1 mes. Evaluación por urología. Realizar APE en diferido (dado instrumentalización reciente)

Gastro: Úlcera forrest III gástrica y cicatriz de úlcera subcardial. Con indicación de biopsia. Solicitar hr en CDT. Como parte de estudio de TEP se solicita colonoscopia.

Mantener laxantes osmóticos dado constipación crónica.

ETE: Pcte con contraindicación de anticoagulación dado sangrado digestivo reciente y hematomas descritos. Se controlará imagenológicamente en 1 mes. Y con esto definir reinicio con NOAC.

Dermato: Evaluación por TEP provocado. Buscar lesiones neoplásicas malignas.

Fecha Epicrisis : 28/03/2022 13:32

Página 3 de 4

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 28-03-2022 13:32:45

Página 4 de 4

Rehabilitación:

Progresar en rehabilitación motora hasta autovalencia con hospitalización domiciliaria.
Progresar en consistencia de régimen.

Consultar en Urgencia en caso de dificultad respiratoria, decaimiento, fiebre persistente, dolor abdominal, salida de sangre por sonda o cese de salida de orina por sonda.

Cambio de sonda foley en un mes en consultorio si no ha visto a urología

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Bajo En Sodio, Potasio Y Fosforo

Medicamentos : Tamsulosina 0.4mg C/24hrs Vo A P Tamsulosina 0.4mg C/24hrs Vo A P
Risperidona 1 Mg C/Sos Vo
Omeprazol 20mg C/12hrs Vo
Lactulosa 65% Fc 1lt 50cc C/12hrs + Abundante Ingesta Hidrica
Kinesioterapia Motora A Diario
Bromuro Ipatropio 0,020 Mcgr Inhalador 2puff C/6hrs X Aec
Bisoprolol 5mg C/24hrs Vo

Controles

S/F - CDT - Urología - prueba miccional

S/F - CDT - Gastroenterología Adulto - EDA + biopsia de ulcera gastrica

S/F - CDT - Gastroenterología Adulto - colonoscopia : constipacion cronica y TEP

S/F - CDT - Dermatología adultos - TEP provocado busqueda de neoplasia

S/F - CDT - Medicina Interna - control FA y evaluar inicio de NOAC segun imagen de control

INTERNO

Becado/Residente


Juan Carlos Claro Garcia-Atance
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 28/03/2022 13:32

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 13:23

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar